

Skills audition

Otoscope (transmission)

- I Allumer la lampe de l'otoscope
- II Pencher la tête du patient du côté opposé à l'otoscope
- III Prendre l'otoscope à horizontale, main par-dessous (changer de main)
- IV Appuyer le poing sur la joue, sert d'appui
- V Tirer l'oreille vers le haut et l'arrière avant introduction de l'otoscope dans l'oreille (protégé par un embout)

Innervation : Pavillon : V3 ant./IX,X conque/VII post. et MAE V3 ant. sup./VII, IX, X post. inf.

*Visible : ant. -inf. cône lumière, strie malléaire du marteau, branche enclume/couleur grise, transparent
Faire attention à ne pas toucher le tympan (profondeur)*



Acoumétrie (transmission/perception)

- I Chuchoter à 60cm de l'oreille deux syllabes (bonjour) tout en effectuant un masquage (éviter travail compensatoire autre oreille) en frottant le tragus, puis monter en intensité

Voie chuchotée : 20-30dB, normal 50-60dB, forte 80-90dB

Weber (transmission/perception, Ca/Co)

- I Faire vibrer le diapason sur le genou/coude et placer le diapason sur le milieu du crâne (vertex) ou du front
- II Demander au patient de quel côté il entend la vibration

Weber centré physiologique, latéralisé pathologique (latéralisé par définition du côté où il entend le mieux)

Déficit de transmission : meilleure audition du côté atteint (masquage non fonctionnel)

Déficit de perception : meilleure audition du côté non atteint

Rinne (évaluer transmission, Ca/Co)

- I Placer le diapason vibrant sur le mastoïde, derrière l'oreille
- II Mettre le diapason dans l'air à proximité de l'oreille et demander au patient d'indiquer lorsqu'il n'entend plus le signal (ou s'il l'entend +/- fort que sur le mastoïde)

Atteinte unilatérale perception, Rinne faussé (diapason non entendu en Co mais en Ca par oreille opposée)

Diapason 70-90dB (surdité sévère)

Skills vision

Inspection œil

Test acuité visuelle

- I Placer le patient face à la feuille à la distance indiquée dessus (6m général)
- II Cacher un œil au patient puis l'autre
- III Faire lire au patient le tableau, physiologique si $\geq 60\%$ correct

Patient ne doit pas se déplacer

Ne teste que le champ visuel fovéal

En cas de myopie/hypermétropie le patient voit les lettres plus petites floues (erreurs $> 40\%$)

Fraction à côté de la ligne indique le pourcentage d'acuité

Test des couleurs (Ishihara)

- I Faire lire au patient le livret composé de planches permettant de mettre en évidence un protanotrope (-cône rouge), deutéranotrope (-cône vert) / d. acquis (névrite, rouge – vif)

Planche 1 : visible par tous, 2-9 chiffres différents vus par malades, 10-17 malades ne voient rien,

18-21 seuls malades voient, 22-25 malades voient un chiffre sur deux

Cacher un œil au patient puis l'autre (atteinte héréditaire touche deux yeux)

Tritanopie non détectée mais rare car récessive (chromosome 7 et non X)

Test de champ visuel

- I Se placer proche du patient (debout) à mi-distance de ses propres mains
- II Demander au patient de cacher un œil puis l'autre et de regarder le nez de l'examineur (test du champ visuel non fovéal)
- III Mettre les mains postéro latéralement à la tête du patient
- IV Test du mouvement, déplacer les mains devant la tête et demander au patient d'indiquer quand il voit la main et où se trouve la main (tester quatre cadrans)
- V Test du cadran, déplacer les doigts dans chaque cadran du champ visuel d'un œil et demander au patient combien de doigts il voit (tester chaque cadran)

L'examineur peut se cacher un œil pour mieux délimiter les quadrans

Cécité unilatérale (nerf optique G)



Hémianopsie bitemporale (chiasma)



Hémianopsie latérale homonyme (tractus optique G)



Quadransopsie latérale hom. (rad. optique G)



Représentation champs visuels/inverse de rétine (atteinte champ temporal signifie défaut niveau rétine nasale)